

ADAPTATION DES ANTIBIOTIQUES A LA FONCTION RENALE

Ce tableau des adaptations posologiques à la fonction rénale des principaux antibiotiques (chez l'adulte, non dialysé) a pour objectif de regrouper toutes les informations sur un support visuel imprimable. Ce document reprend les données issues des sources suivantes à la date du 10/01/2024 :

- RCP des molécules : <https://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/>

- Site GPR : <https://sitegpr.com/fr/> (indications, voies d'administration et posologies usuelles revues et validées dans le cadre d'un travail conjoint SPILF - Site GPR – SFPT - CA-SFM en juin 2023)

- ePOPI

Nous vous recommandons de consulter les sources précédentes pour obtenir plus d'informations et/ou les dernières mises à jour.



Abréviations : DC = dose de charge ; DFG = débit de filtration glomérulaire ; IM = Intramusculaire ; IV = Intraveineuse ; PO = Per os

Stade DFG (mL/min/1,73m ²)	Normorénal ≥ 90	IRC légère 89 → 60	IRC modérée 59 → 30	IRC sévère 30 → 15	IRC terminale < 15
	90	85 80 75 70 65 60	55 50 45 40 35 30	25 20 15	10 5 0
Bêta-lactamines : Pénicillines +/- inhibiteurs de bêta-lactamases					
Amoxicilline PO	1 g/8h			DC de 1 g puis 500 mg/8h	DC de 1 g puis 750 mg/24h
	1 g/12h			DC de 1 g puis 500 mg/12h	DC de 1 g puis 500 mg/24h
Amoxicilline IV	100 mg/kg/24h en 4 injections			50 mg/kg/24h	25 mg/kg/24h
	200 mg/kg/24h en 6 injections			100 mg/kg/24h	50 mg/kg/24h
Amoxicilline + acide clavulanique PO	1 g/8h			DC de 1 g puis 500 mg/8h	DC de 1 g puis 750 mg/24h
	Posologies exprimées en g d'amoxicilline				
Amoxicilline + acide clavulanique IV	1 g/8h			DC de 1 g puis 500 mg/8h	DC de 1 g puis 750 mg/24h
	2 g/8h			3 g/24h	1,5 g/24h
	Posologies exprimées en g d'amoxicilline ; /!\ acide clavulanique : dose max 200 mg/injection et 1200 mg/24h				

ADAPTATION DES ANTIBIOTIQUES A LA FONCTION RENALE

Stade DFG (mL/min/1,73m2)	Normorénal ≥ 90				IRC légère 89 → 60				IRC modérée 59 → 30				IRC sévère 30 → 15			IRC terminale < 15			
	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0
Ampicilline + Sulbactam IV	Posologie usuelle : 1 à 2 g /6 à 12h												DC de 1 g puis 500 mg/12h			DC de 1 g puis 250 mg/12h			
	Infection à Acinetobacter spp : 3 g /6 à 8h												3 g/12h			3 g/24h			
	Posologies exprimées en g d'ampicilline																		
Ampicilline + Sulbactam IM	1 g/12h												500 mg/12h			250 mg/12h			
	Posologies exprimées en g d'ampicilline																		
Benzathine benzylpenicilline IM	2,4 MUI tous les 8 jours								1,8 MUI tous les 8 jours						Aucune donnée				
	1,2 MUI toutes les 3 à 4 semaines								0,9 MUI toutes les 3 à 4 semaines						Aucune donnée				
Benzylpenicilline sodique IM ou IV	12 à 24 MUI/j en 6 injections ou en perfusion continue								3 MUI /4h	2 MUI/4h		1 MUI/4h			0,5 MUI/6h				
Cloxacilline PO	50 mg/kg/24h en 3 prises (sans dépasser 4 g/24h)												Aucune donnée						
Cloxacilline IV	100 à 200 mg/kg/24h en 6 perfusions de 30 à 60 min OU DC de 2 g en perfusion de 60 min puis 100 à 200 mg/kg/24h en perfusion continue												Aucune donnée						
Oxacilline IV	100 à 200 mg/kg/24h en 6 perfusions de 30 à 60 min toutes les 4h OU DC de 2 g en perfusion de 60 min puis 100 à 200 mg/kg/24h en perfusion continue																		
Phénoxyméthyl- -pénicilline PO	1 MUI/6 à 8h															Aucune donnée			
Pipéracilline IV	4 g/6 à 8h										4 g/ 8h			4 g/12h					

ADAPTATION DES ANTIBIOTIQUES A LA FONCTION RENALE

Stade DFG (mL/min/1,73m2)	Normorénal ≥ 90				IRC légère 89 → 60				IRC modérée 59 → 30				IRC sévère 30 → 15				IRC terminale < 15			
	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	
Pipéracilline + tazobactam IV	4 g/6 à 8h												4 g/ 8h				4 g/12h			
	Posologies exprimées en g de pipéracilline																			
Pivmécillinam PO	400 mg/8 à 12h												DC de 400 mg puis 200 mg/8 à 12h				DC de 400 mg puis 200 mg /24h			
Témocilline IV	2 g/8 à 12h en perfusion de 30 min								1 g/12h				1 g/24h				500 mg/24h			
	DC de 2 g en perfusion de 30 min puis 6 g/24h en perfusion continue								Aucune donnée											
Bêta-lactamines : Monobactames																				
Aztréonam IM	Cystite aiguë ou infection gonococcique non compliquée : 1 g dose unique																			
	Infection urinaire haute et/ou compliquée : 1 g/12h												½ dose				¼ dose			
Aztréonam IV	Infection peu sévère : DC de 2 g puis 1 à 2 g/8h												DC de 2 g puis 500 mg à 1 g/8h				DC de 2 g puis 250 à 500 mg/8h			
	Infection sévère : 2 g/6h ou 8 g/24h en continue												DC de 2 g puis 1 g/6h ou 4 g/24h en continue				DC de 2 g puis 500 mg/6h ou 2 g/24h en continue			
Bêta-lactamines : Céphalosporines																				
Céfaclor PO	250 à 500 mg/8h Posologie max : 1500 mg/24h												250 à 500 mg/12h				250 à 500 mg/24h			
Céfadroxil PO	1 g/12h										500 mg/12h				500 mg/24h					
Céfalexine PO	1 g/12h								500 mg/12h				500 mg/24h				250 mg/12 à 24h			

ADAPTATION DES ANTIBIOTIQUES A LA FONCTION RENALE

Stade DFG (mL/min/1,73m2)	Normorénal ≥ 90	IRC légère 89 → 60						IRC modérée 59 → 30						IRC sévère 30 → 15			IRC terminale < 15			
		90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0
Céfazoline IM IV	Infection peu sévère : 60 à 80 mg/kg/24h en 4 à 6 injections OU en continue avec DC = 1/4 ou 1/3 de la dose journalière								DC de 500 mg puis 125 à 250 mg/12h						DC de 500 mg puis 125 à 250 mg/24h			DC de 500 mg puis 125 à 250 mg/48h		
	Infection sévère : 80 à 100 mg/kg/24h en 3 perfusions de 60 min toutes les 8h OU en continue avec DC de 2 g en perfusion de 60 min puis 80 à 100 mg/kg/j en 2 perfusions de 12h								DC de 500 mg puis 250 mg/6h ou 500 mg/12h						DC de 500 mg puis 250 mg/12h ou 500 mg/24h			DC de 500 mg puis 500 mg/48 à 72h		
Céfépime IV (*IM possible)	Infection respiratoire communautaire, pyélonéphrite non compliquée : 1 g/12h *										1 g/24h		0,5 g/24h				0,25 g/24h			
	Infection sévère : 2 g/12h										2 g/24h		1 g/24h				0,5 g/24h			
	Infection très sévère : 2 g/8h										1 g/8h		1 g/12h				1 g/24h			
Céfidérol IV	2 g/8h si fonction rénale ≥ 120 mL/min : 2 g/ 6h	2 g/8h						1,5 g/8h						1 g/8h			0,75 g/12h			
	Si fonction rénale ≥ 120 mL/min : 2 g/6h																			
Céfixime PO	200 mg/12h															200 mg/24h				
Céfotaxime IM IV	Posologie standard : 1 à 2 g/8h								1 à 2 g/12h						750 à 1500 mg/12h			750 à 1500 mg/24h		
	Infection ostéo-articulaire : 100 à 150 mg/kg/24h en 4 à 6 injections ou en continue								75 à 112,5 mg/kg/24h						50 à 75 mg/kg/24h			25 à 37,5 mg/kg/24h		
	Infection méningée : 200 à 300 mg/kg/24h en 4 à 6 injections ou en continue								150 à 225 mg/kg/24h						100 à 150 mg/kg/24h			50 à 75 mg/kg/24h		

ADAPTATION DES ANTIBIOTIQUES A LA FONCTION RENALE

Stade DFG (mL/min/1,73m2)	Normorénal ≥ 90	IRC légère 89 → 60						IRC modérée 59 → 30						IRC sévère 30 → 15			IRC terminale < 15			
		90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0
Céfoxitine IV	Infection peu grave : 1 à 2 g/8h								1 à 2 g/8 à 12h				1 à 2 g/12 à 24h				0,5 à 1g/24 à 48h			
	Infection grave et/ou à CMI>8mg/l : 8 g/24h en continue								Aucune donnée											
Cefpodoxime (proxetil) PO	100 à 200 mg/12h								100 à 200 mg/12 à 24h				100 à 200 mg/24h							
Ceftaroline (fosamil) IV	600 mg/12h								400 mg/12h				300 mg/12h				200 mg/12h			
Ceftazidime IM IV	Administration discontinue : 2 g/8h								2 g/12h				2 g/24h				1 g/24h			
	Administration continue : DC de 2 g puis 6 g/24h								DC de 2 g puis 3 g/24h				DC de 2 g puis 1 g/24h				Aucune donnée			
Ceftazidime + avibactam IV	Administration discontinue : 2 g/8h en perfusion de 2h								1 g/8h				0,75 g/12h				0,75 g/24h			
	Administration en continue : DC de 2 g puis 6 g/24h								Aucune donnée sur l'administration en continue											
	Posologies exprimées en g de ceftazidime																			
Ceftobiprole IV	500 mg /8h en perfusion de 2h Si infection sévère : 1 g/8h en perfusion de 4h								500 mg/12h				250 mg/12h				250 mg/24h			
Ceftolozane + tazobactam IV	1 g/8h en perfusion de 60 min								500 mg/8h				250 mg /8h				DC de 500 mg puis 8h plus tard 100 mg/8h			
	Si pneumonie nosocomiale : 2 g/8h en perfusion de 60 min								1 g/8h				500 mg/8h				DC 1500 mg puis 8h plus tard 300 mg/8h			
	Posologies exprimées en g de ceftolozane																			

ADAPTATION DES ANTIBIOTIQUES A LA FONCTION RENALE

Stade DFG (mL/min/1,73m2)	Normorénal ≥ 90	IRC légère 89 → 60						IRC modérée 59 → 30						IRC sévère 30 → 15			IRC terminale < 15			
	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	
Ceftriaxone IM IV	Infection modérée : 1 à 2 g/24h Infection sévère : 2 à 4 g/24h Si infection neuroméningée : 75 à 100 mg/kg/24h ; Aucune donnée chez l'insuffisant rénal																			
Cefuroxime (axétil) PO	250 à 500 mg/12h												250 à 500 mg/24h			250 à 500 mg/48h				
Cefuroxime IV	2 à 6 g/24h			2 g/24h									1 g/24h			1 g/24 à 48h				
Bêta-lactamines : Carbapénèmes																				
Ertapénem IV	1 g/ 24h												500 mg/24h							
Imipénem + cilastatine IV	500 mg/6h en perfusion de 30 min						500 mg/8h				250 mg/6h				250 mg/12h					
	1000 mg/8h en perfusion de 30 min						500 mg/6h				500 mg/8h				500 mg/12h					
	1000 mg/6h en perfusion de 30 min						750 mg/8h				500 mg/6h				500 mg/12h					
	Posologies exprimées en mg d'Imipénem																			
Imipénem + cilastatine + relebactam IV	500 mg/6h en perfusion de 30 min			400 mg/6h				300 mg/6h				200 mg/6h				Aucune donnée				
	Posologies exprimées en mg d'Imipénem																			
Méropénem IV	1 à 2 g/8h									1 à 2 g/12h				0,5 à 1 g/12h						
	Si posologie élevée (> 6 g/24h) : monitoring pharmacologique																			
Méropénem + vaborbactam IV (ATB de réserve)	2 g/8h en perfusion de 3h									1g/8h				1g/12h		0,5g/12h				
	Posologies exprimées en g de meropenem																			

ADAPTATION DES ANTIBIOTIQUES A LA FONCTION RENALE

Stade DFG (mL/min/1,73m2)	Normorénal ≥ 90	IRC légère 89 → 60	IRC modérée 59 → 30	IRC sévère 30 → 15	IRC terminale < 15
	90	85 80 75 70 65 60	55 50 45 40 35 30	25 20 15	10 5 0
Aminosides					
Amikacine IV	15 à 30 mg/kg/j	En cas de situation clinique justifiant l'administration, la posologie unitaire ne doit pas être diminuée. Dans la majorité des cas, une injection unique suffit. Si plusieurs injections sont nécessaires, il est indispensable de réaliser des dosages du résiduel et d'espacer les doses.			
Gentamicine IM IV	3 à 8 mg/kg/j				
Tobramycine IM IV	3 à 8 mg/kg/j				
Fluoroquinolones					
Ciprofloxacin PO	500 à 750 mg/12h		250-500 mg/12h	250-500 mg/24h	
Ciprofloxacin IV	400 mg/8 à 12h		400 mg/12h	400 mg/24h	
Délafoxacin PO	450 mg/12h				Déconseillé
Délafoxacin IV	300 mg/ 12 h en perfusion de 60 min			200 mg/12 h	Déconseillé
Lévofoxacin IV PO	500 mg/12 à 24h		DC de 500 mg puis 250 mg/12 à 24h	DC de 500 mg puis 250 mg/24 à 48h	DC de 500 mg puis 125 à 250 mg/48h
	Cystite non compliquée : 250 mg /24h		DC de 250 mg puis 125 mg/24h		DC de 250 mg puis 125 mg/48h
Moxifloxacin IV PO	400 mg/24h				
Norfloxacin PO	400 mg/12 à 24 h			400 mg/24h	
Ofloxacin IV PO	Dose usuelle : 200 mg/12h		200 mg/24h		200 mg/48h
	Infection sévère : 400 mg/12h		400 mg/24h		200 mg/24h OU 400 mg/48h

ADAPTATION DES ANTIBIOTIQUES A LA FONCTION RENALE

Stade DFG (mL/min/1,73m2)	Normorénal ≥ 90	IRC légère 89 → 60						IRC modérée 59 → 30						IRC sévère 30 → 15			IRC terminale < 15			
		90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0
Glycopeptides																				
Dalbavancine IV	1500 mg en une seule perfusion OU 1000 mg en perfusion de 30 min suivi de 500 mg 7 jours après													1000 mg en une seule perfusion OU 750 mg suivi de 375 mg 7 jours après						
Oritavancine IV	1200 mg (dose unique) en perfusion de 3h													Aucune donnée						
Teicoplanine IM IV	Infection peu sévère : DC de 6 mg/kg/12h les 3 premières injections puis 6 mg/kg/24h							DC de 6 mg/kg/12h les 3 premières injections puis 3 mg/kg/24h ou 6 mg/kg/48h						DC de 6 mg/kg/12h les 3 premières injections puis 2 mg/kg/24h ou 6 mg/kg/72h						
	Infection sévère : DC de 12 mg/kg/12h les 3 à 5 premières injections puis 12 mg/kg/24h							DC de 12 mg/kg/12h les 3 à 5 premières injections puis 6 mg/kg/24h ou 12 mg/kg/48h						DC de 12 mg/kg/12h les 3 à 5 premières injections puis 4 mg/kg/24h ou 12 mg/kg/72h						
Teicoplanine PO	Diarrhée et colite associées à une infection à Clostridium difficile : 100 - 200 mg deux fois par jour pendant 7 à 14 jours.																			
Vancomycine IV	DC 30 mg/kg en perfusion de 2h puis : 20 à 40 mg/kg/j		DC, puis adapter en fonction de la concentration plasmatique à l'équilibre																	
Vancomycine PO	Traitement des infections à Clostridium difficile (ICD) : 125 mg/ 6h pendant 10 jours pour un 1er épisode d'ICD non sévère. Cette dose peut être augmentée à 500 mg/6h pendant 10 jours en cas d'ICD sévère ou compliquée. La dose maximale journalière ne devrait pas dépasser 2g.																			
Imidazolés																				
Métronidazole PO	250 mg/6h															250 mg/12h				
	500 mg/8h															250 mg/8h				
	500 mg/12h															500 mg/24h				
Métronidazole IV	500 mg/8h															250 mg/8h				
	750 mg/8h															375 mg/8h				
Ornidazole IV PO	Infection à germes anaérobies : 1 à 1,5g /24h																			

ADAPTATION DES ANTIBIOTIQUES A LA FONCTION RENALE

Stade DFG (mL/min/1,73m2)	Normorénal ≥ 90				IRC légère 89 → 60				IRC modérée 59 → 30				IRC sévère 30 → 15				IRC terminale < 15			
	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	
Macrolides, lincosamides, streptogramines																				
Azithromycine PO	Selon indication : 1 g en prise unique OU 500 mg de J1 à J3 OU 500 mg à J1 puis 250 mg de J2 à J5																			
Clarithromycine PO	250 mg/12h												250 mg/24h							
	500 mg/12h												500 mg/24h							
Clarithromycine IV	500 mg/12h												500 mg/24h							
Clindamycine IV PO	600 mg/6 à 8h																			
Erythromycine IV PO	1 g/8 à 12h															500 à 750 mg/8 à 12h				
Pristinamycine PO	1 g/8 à 12h (posologie maximale = 4 g/24h)																			
Roxithromycine PO	150 mg/12h															150 mg/24h				
Spiramycine IV PO	Per os : 3 MUI/8 à 12h																			
	IV : 1,5 à 3 MUI/8h																			
Spiramycine + Métronidazole PO	1,5 MUI (spiramycine) + 250 mg (métronidazole) /8h															1,5 MUI (spiramycine) + 125 mg (métronidazole) /8h				

ADAPTATION DES ANTIBIOTIQUES A LA FONCTION RENALE

Stade DFG (mL/min/1,73m2)	Normorénal ≥ 90				IRC légère 89 → 60				IRC modérée 59 → 30				IRC sévère 30 → 15				IRC terminale < 15			
	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	
Sulfamides																				
Cotrimoxazole IV PO	800 mg de sulfaméthoxazole + 160 mg de triméthoprim / 12h													800 mg/160 mg/24h			Contre-indiqué			
Sulfadiazine PO	Préventif : 2 g/j Curatif : 4 à 6 g/j en 4 à 6 prises				Réduction de la posologie								Aucune donnée							
Triméthoprim PO	Cystite aiguë non compliquée : 300 mg/j en 1 prise, pendant 3 jours													Aucune donnée						
Tétracyclines																				
Doxycycline IV PO	Patient > 60 kg : 200 mg/24h en 1 prise Patient < 60 kg : 200 mg le 1er jour puis 100 mg/24h les jours suivants Autres posologies dans des cas particuliers : gonococcie aiguë, syphilis, urétrite non compliquée, endocervicite, ...																			
Lymecycline PO	300 mg/12h				Aucune donnée															
	Acné : 300 mg/24h				Aucune donnée															
Minocycline PO	200 mg/j en 2 prises																			
Tigécycline IV	Infection non sévère : DC de 100 mg puis 50 mg/12h																			
	Infection sévère : DC de 200 mg puis 100 mg/12h																			

ADAPTATION DES ANTIBIOTIQUES A LA FONCTION RENALE

Stade DFG (mL/min/1,73m2)	Normorénal ≥ 90				IRC légère 89 → 60				IRC modérée 59 → 30				IRC sévère 30 → 15			IRC terminale < 15			
	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0
Autres																			
Acide Fusidique IV PO	500 mg/8 à 12h																		
Colistine IV (Colistiméthate sodique)	DC de 9 MUI en perfusion de 30 min puis 9 MUI/24h en 2 ou 3 administrations								DC de 9 MUI puis 5,5 à 7,5 MUI/24h en 2 perfusions			DC de 9 MUI puis 4,5 à 5,5 MUI/24h en 2 perfusions				DC de 9 MUI puis 3,5 MUI/24h en 2 perfusions			
Daptomycine IV	Infection non sévère : 6 à 8 mg/kg en perfusion de 30 min, 1 fois/24h													6 à 8 mg/kg/48h					
	Infection sévère : 10 à 12 mg/kg en perfusion de 30 min, 1 fois/24h													Aucune donnée au-delà de 10 mg/kg/48h					
Fidaxomicine PO	200 mg/12h																		
Fosfomycine trométamol PO	Cystite aiguë non compliquée de la femme et adolescente de + de 12 ans : 3 g en prise unique																		
Fosfomycine IV	8 à 16 g/24h, en perfusion de 4 g, sur 30 min à 4h, toutes les 6 à 12h (max 8 g/prise)							4 g toutes les 12 à 24h				4 g toutes les 36 à 48h			2 g toutes les 48h				
Linezolide IV PO	600 mg/12h													600 mg/24h					
	Infections graves de réanimation : 600 mg/8h													Aucune donnée					
Nitrofurantoïne PO	100 mg/8h							Déconseillé				Contre-indiqué							
Tédizolide PO	200 mg/24h																		

ADAPTATION DES ANTIBIOTIQUES A LA FONCTION RENALE

Stade DFG (mL/min/1,73m2)	Normorénal ≥ 90				IRC légère 89 → 60				IRC modérée 59 → 30				IRC sévère 30 → 15			IRC terminale < 15				
	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0	
Antituberculeux																				
Bédaquiline PO	Semaines 1 et 2 : 400 mg, 1 fois par jour Semaines 3 à 24 : 200 mg, 3 fois par semaine, avec un intervalle d’au moins 48 heures entre chaque prise													Aucune donnée						
Delamanide PO	100 mg deux fois par jour pendant 24 semaines													Aucune donnée						
Ethambutol M IV PO	15 à 20 mg/kg/24h (25 mg/kg/j maximum)			15 mg/kg/j			10 mg/kg/j													
Isoniazide IM IV PO	4 à 5 mg/kg/24h (300 mg/j maximum)			3 à 5 mg/kg/24h										3 à 5 mg/kg/24h (200 mg/j maximum)						
Pyrazinamide PO	30 mg/kg/24h en 1 prise /j													30 mg/kg/48h						
Rifabutine PO	Traitement curatif des infections à Mycobacterium avium complexe chez les sujets VIH+ : poids > 50 kg : 600 mg/j poids < 50 kg : 450 mg/j Si association avec la Clarithromycine : 300 mg/j													Poids > 50 kg : 300 mg/24h Poids < 50 kg : 450 mg/48h Si association avec la Clarithromycine : 150 mg/j						
	Traitement préventif des infections à Mycobacterium avium complexe chez les sujets VIH+ : 300 mg/j en une prise Si association avec Indinavir ou Nelfinavir : 150 mg/j													150 mg/24h Si association avec Indinavir ou Nelfinavir : 150 mg/48h						
Rifampicine IV PO	Tuberculose : 8 à 12 mg/kg/24h																			
	Infection à germes gram + ou - : 20 à 30 mg/kg/24h							espacer les prises si besoin selon rifampicémie du 2 ^{me} ou 3 ^{me} jour du traitement							espacement des prises indispensable					